

## FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

## EAT-40 · TEST DE ACTITUDES HACIA LA ALIMENTACIÓN (FORMATO OFICIAL SERGAS)

*Eating Attitudes Test – Instrumento de referencia para detección precoz y cribado de riesgo de TCA en el Sistema Nacional de Salud*

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

|                      |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Oficial       | Eating Attitudes Test (EAT-40) - Formato Protocolizado SERGAS / SNS                                                                                                             |
| Autores Originales   | David M. Garner y Paul E. Garfinkel (1979)                                                                                                                                      |
| Validación Española  | Josep Castro, Josep Toro, Manel Salameiro y Ernest Guimerà (1991)                                                                                                               |
| Tipo de Instrumento  | Autoinforme estructurado de actitudes patológicas y conductas alimentarias                                                                                                      |
| Población Diana      | Adolescentes y adultos (población general y clínica a partir de los 12 años)                                                                                                    |
| Tiempo de Aplicación | 7 a 10 minutos (40 reactivos tipo Likert de 6 opciones)                                                                                                                         |
| Formato de Respuesta | Escala Likert de 6 puntos: Nunca (0) a Siempre (3) (con 6 ítems invertidos)                                                                                                     |
| Finalidad Clínica    | Detección precoz, cribado epidemiológico y evaluación psicométrica de actitudes, preocupaciones y conductas restrictivas o purgativas propias de la anorexia y bulimia nerviosa |

## 2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El Test de Actitudes hacia la Alimentación (EAT), desarrollado en el Clarke Institute of Psychiatry por Garner y Garfinkel, es el instrumento psicométrico pionero y de mayor impacto histórico internacional en el ámbito de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Fue formulado para cuantificar una constelación de síntomas cognoscitivos, emocionales y comportamentales nucleares compartidos por los cuadros anoréxicos y bulímicos: la fobia al aumento ponderal, la preocupación obsesiva y distorsionada por la comida y las calorías, el impulso irrefrenable hacia la delgadez extrema y los rituales restrictivos.

Incorporado de manera oficial en las guías de práctica clínica del Servizo Galego de Saúde (SERGAS) y en protocolos de salud mental del Sistema Nacional de Salud español, el EAT-40 opera como un filtro de triaje insustituible en atención primaria, servicios de pediatría y gabinetes escolares. Su formulación original de 40 reactivos proporciona una evaluación exhaustiva del conflicto con la ingesta y de los sentimientos de culpa asociados al acto alimentario, capturando alteraciones antes de que se manifieste un colapso nutricional irreversible.

## 3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

| Factor / Dominio          | Nº Ítems | Ítems Clave             | Contenido Evaluado                                                                |
|---------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dieta y Restricción       | 18 ítems | 1, 6, 7, 10, 11, 14, 16 | Evitación obsesiva de alimentos calóricos, conteo y deseo de estar más delgado/a. |
| Bulimia y Preocupación    | 9 ítems  | 3, 4, 9, 18, 21, 25, 39 | Pensamiento continuo en la comida, episodios de atracón y vómito autoinducido.    |
| Control Oral y Social     | 8 ítems  | 2, 5, 8, 13, 20, 26, 32 | Autocontrol de la ingesta y percepción de presión social para ganar peso.         |
| Presión Social / Familiar | 5 ítems  | 12, 19, 23, 27, 33      | Creencia de que los demás prefieren que la persona coma más o gane peso.          |

*Ítems de corrección invertida:* Los reactivos 1, 18, 19, 23, 27 y 39 reflejan conductas o actitudes adaptativas hacia la ingesta y deben puntuarse en sentido inverso.

## PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · EAT-40

## 4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

|                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistencia Interna</b>         | Alfa de Cronbach = 0.92 en población clínica diagnosticada de anorexia/bulimia en España (Castro et al., 1991) y 0.88 en estudiantes.                   |
| <b>Sensibilidad y Especificidad</b> | Con punto de corte clásico $\geq 30$ : Sensibilidad diagnóstica = 94.6%, Especificidad = 85.2%, Área Bajo la Curva ROC = 0.93 frente a diagnóstico DSM. |
| <b>Validez Concurrente</b>          | Correlación elevada con el Eating Disorder Inventory (EDI-2, $r = 0.81$ ), el Body Shape Questionnaire (BSQ, $r = 0.77$ ) y el BITE ( $r = 0.73$ ).     |
| <b>Capacidad de Triaje</b>          | Excelente poder de discriminación entre pacientes anoréxicas restrictivas, subtipo purgativo y controles sanos de la misma edad.                        |

## 5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

## 1. Escala de Puntuación Asimétrica Clásica (0 a 3 puntos):

- Para los ítems directos (34 ítems):
  - Siempre = **3 puntos**; Casi siempre = **2 puntos**; A menudo = **1 punto**; A veces = **0 puntos**; Raras veces = **0 puntos**; Nunca = **0 puntos**.
- Para los ítems invertidos (Ítems 1, 18, 19, 23, 27 y 39):
  - Nunca = **3 puntos**; Raras veces = **2 puntos**; A veces = **1 punto**; A menudo = **0 puntos**; Casi siempre = **0 puntos**; Siempre = **0 puntos**.

2. **Puntuación Total:** Suma directa de las puntuaciones asignadas a los 40 ítems.3. **Rango de Puntuación:** De 0 a 120 puntos.

## 6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

| Puntuación EAT-40 | Estratificación               | Probabilidad TCA | Conducta Clínica Asistencial                                             |
|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0 a 19 puntos     | Sin Riesgo Aparente           | Baja (< 5%)      | Actitud alimentaria adaptativa normal.                                   |
| 20 a 29 puntos    | Riesgo Moderado / Sub-clínico | Media (20-30%)   | Preocupaciones por el peso; consejo preventivo y reevaluación.           |
| 30 a 49 puntos    | Cribado Positivo (TCA)        | Alta (> 85%)     | Derivación preferente a Unidad de Salud Mental / TCA.                    |
| $\geq 50$ puntos  | TCA Muy Severo / Grave        | Extrema (> 95%)  | Sospecha fundada de Anorexia / Bulimia grave; despistaje médico urgente. |

**PUNTO DE CORTE CLÁSICO INTERNACIONAL (EAT-40  $\geq 30$ ):** Una puntuación igual o superior a 30 puntos es el umbral validado en España por Castro et al. (1991) para cribado positivo de TCA. Requiere una exploración física completa inmediata (Índice de Masa Corporal, constantes vitales) y analítica con ionograma para descartar desnutrición o hipopotasemia por purgas.

## APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · EAT-40

## 7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

**Paso 1: Aplicación en Atención Primaria o Salud Escolar:** Administrar ante sospecha clínica, pérdida de peso no filiada, amenorrea secundaria o vómitos recurrentes.

**Paso 2: Triage y Toma de Decisiones Asistenciales:**

- Si EAT-40 < 30 y exploración normal: Bajo riesgo de TCA primario. Dar pautas de nutrición saludable y vigilar evolución si existe pérdida de peso.
- Si EAT-40 ≥ 30:
  1. Evaluar de inmediato Índice de Masa Corporal (IMC en kg/m<sup>2</sup>), tensión arterial y frecuencia cardíaca.
  2. Solicitar analítica urgente con electrolitos (Na, K, Cl), función renal y ECG (medición de intervalo QTc).
  3. Si IMC < 15 kg/m<sup>2</sup>, bradicardia (< 45 lpm), hipotensión severa o arritmias, derivar a urgencias hospitalarias para ingreso médico.
  4. Si situación médica estable, derivar a Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA) para abordaje psicoterapéutico y nutricional integral.

## 8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

**Identificación:** Mujer de 16 años, estudiante de bachillerato, traída a consulta de pediatría por sus progenitores tras notar una pérdida de 8 kg en los últimos 4 meses, uso de ropa holgada y aislamiento durante las comidas familiares.

**Evaluación Psicométrica Inicial:** EAT-40 = 54 / 120 puntos (Cribado Altamente Positivo para TCA Grave).

- Puntuaciones máximas en la subescala de Dieta y Restricción: afirma contar obsesivamente las calorías de cada alimento (ítem 6 = Siempre), sentir un pavor insoportable a tener sobrepeso (ítem 1 = Nunca → 3 puntos) y trocear minuciosamente la comida (ítem 28 = Siempre).
- Admite inducirse el vómito si se siente culpable tras cenar (ítem 9 = A menudo).

**Exploración Médica y Manejo:** Peso actual: 42 kg, Talla: 1.64 m, IMC: 15.6 kg/m<sup>2</sup> (desnutrición moderada). Frecuencia cardíaca: 48 lpm. Ionograma: K = 3.1 mEq/L (hipopotasemia por purgas). Se diagnosticó Anorexia Nerviosa de subtipo compulsivo/purgativo según criterios DSM-5. Se gestionó ingreso preferente en hospital de día de TCA infanto-juvenil para renutrición monitorizada, reposición de potasio y psicoterapia familiar basada en el modelo Maudsley. A los 6 meses, con IMC recuperado a 19.2 kg/m<sup>2</sup>, el EAT-40 se redujo a 18 puntos.

## 9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

## ALERTAS MÉDICAS CRÍTICAS EN TCA

- Riesgo inminente de parada cardíaca por prolongación del QTc e hipopotasemia secundaria a purgas o abuso de diuréticos.
- La desnutrición severa (IMC < 13 kg/m<sup>2</sup>) y el síndrome de realimentación son emergencias médicas vitales de ingreso hospitalario inmediato.

## DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Enfermedades Orgánicas Consuntivas:** Enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, hipertiroidismo o diabetes mellitus tipo 1.
- **Depresión Mayor con Anorexia:** Pérdida de apetito sin distorsión de la imagen corporal ni deseo activo de adelgazar.

## 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Garner, D. M., & Garfinkel, P. E. (1979). The Eating Attitudes Test: An index of the symptoms of anorexia nervosa. *Psychological Medicine*, 9(2), 273–279.
- Castro, J., Toro, J., Salameiro, M., & Guimerá, E. (1991). The Eating Attitudes Test: Validation of the Spanish version. *Psychological Medicine*, 21(1), 175–180.
- Servizo Galego de Saúde (SERGAS). (2006). *Guía de práctica clínica sobre trastornos de la conducta alimentaria*. Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia.
- Garner, D. M., Olmsted, M. P., Bohr, Y., & Garfinkel, P. E. (1982). The Eating Attitudes Test: Psychometric features and clinical correlates. *Psychological Medicine*, 12(4), 871–878.